Apoyo práctico en la atención cotidiana

Recurso complementario para personas que apoyan a alguien durante momentos difíciles

Cuando a alguien no se le calma el cuerpo

Comprender qué puede estar pasando

La inquietud, la tensión y la dificultad para calmarse pueden tener causas físicas, emocionales, ambientales o relacionadas con la medicación. Pregunta si siente molestias y qué le resulta difícil ahora; no des por hecho que se debe a la ansiedad.

Considerar qué se puede cambiar

Comprueba el ruido, la iluminación, la temperatura, si hay demasiada gente, las interrupciones, la intimidad, los asientos y las oportunidades de moverse. Pregunta si la persona estaría más cómoda en otro espacio o con alguien de confianza. Si es posible, reduce las restricciones evitables o aclara las rutinas confusas. Piensa si la cercanía del personal, las instrucciones repetidas o las respuestas de frustración aumentan la presión; si hace falta, pide apoyo al equipo o reflexiona con colegas.

Ofrecer apoyo práctico

Ayuda a la persona a encontrar un lugar cómodo, conseguir agua u otras cosas necesarias, o comunicar una preocupación al profesional adecuado. Escucha y dale espacio sin exigirle una explicación. Una presencia tranquila y atenta puede ayudar sin añadir otra actividad.

Probar algo en compañía

Si la persona quiere, proponle un paseo cómodo o un movimiento accesible, música que ella elija, una actividad manual conocida o un ejercicio de relajación opcional. Pregunta qué le ha ayudado antes. Cualquier recurso sensorial debe elegirse junto con la persona, no imponerse.

Decisión y seguridad

Evita el contacto físico no deseado, forzar ejercicios de respiración o utilizar actividades para obtener obediencia. Los síntomas físicos nuevos, intensos o inusuales, los cambios importantes de conducta o la inquietud que pudiera estar relacionada con la medicación requieren una valoración adecuada; los síntomas urgentes requieren atención urgente.

Una posible invitación:«¿Te ayudaría cambiar de espacio o prefieres que me quede aquí contigo?»

Nota sobre la evidencia:Las orientaciones profesionales respaldan la desescalada mediante el entorno y la relación (NICE NG10; Helsedirektoratet; NHS England). Te Pou ofrece recomendaciones prácticas sobre modulación sensorial, pero la evidencia de actividades informales concretas es variable y, a menudo, indirecta. No afirmes que previenen la agresividad o las medidas de contención.

Cuando alguien queda atrapado en pensamientos o preocupaciones

Comprender qué puede estar pasando

Pregunta si hay alguna pregunta sin respuesta, una duda práctica, algo que quiera hablar o algo que prefiera no comentar. Los pensamientos repetitivos no siempre son preocupaciones habituales.

Considerar qué se puede cambiar

Reduce los mensajes contradictorios, las interrupciones innecesarias y la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. Averigua si una respuesta clara, un seguimiento previsible o un cambio en la atención resolverían una preocupación concreta.

Ofrecer apoyo práctico

Escucha sin corregir ni cuestionar enseguida lo que la persona piensa. Ayuda a obtener información fiable, apunta una pregunta para un profesional o aborda una preocupación que se pueda resolver. Explica la información en partes manejables y comprueba con respeto que se ha entendido. Parte de lo que la persona ya ha contado y evita pedirle que repita su historia sin necesidad.

Probar algo en compañía

Si la persona quiere, anota una preocupación que desee recordar, ocúpate de una tarea práctica o pasa un rato con una actividad conocida. Si es adecuado, podéis acordar hablar más tarde; no aplaces algo urgente para quitarle importancia.

Decisión y seguridad

No insistas en distraer, no ofrezcas garantías generales ni intentes hacer psicoterapia si no te corresponde o no tienes la preparación adecuada. La confusión importante, los cambios en el pensamiento, el malestar intenso, las dificultades para funcionar o los problemas de seguridad requieren una valoración adecuada. Repetir garantías puede no ayudar en algunos patrones compulsivos, pero no se debe negar automáticamente el consuelo habitual ni la información fiable.

Una posible invitación:«¿Te ayudaría hablar, buscar la respuesta a algo o hacer otra cosa juntos un rato?»

Nota sobre la evidencia:NICE CG113 y CG31 respaldan intervenciones clínicas estructuradas y advierten sobre las garantías repetidas en patrones compulsivos; AHRQ recomienda comprobar que la información sanitaria se haya explicado con claridad; las orientaciones canadienses centradas en la recuperación respaldan el trabajo en colaboración. Ninguna de estas fuentes establece que la distracción informal trate la rumiación.

Cuando todo parece demasiado

Comprender qué puede estar pasando

Averigua qué exigencias, incertidumbres o responsabilidades pesan ahora. La sobrecarga puede deberse a dificultades prácticas, servicios inaccesibles, enfermedad o presiones institucionales; no necesariamente a una falta de estrategias de afrontamiento.

Considerar qué se puede cambiar

Reduce las interrupciones evitables, las instrucciones contradictorias y las decisiones innecesarias. Aclara las prioridades, adapta los horarios si es posible y pregunta si el servicio puede eliminar o compartir alguna carga.

Ofrecer apoyo práctico

Ayuda con una cita, un formulario, un transporte, una comunicación u otra tarea que elija la persona. Coordínate con colegas para evitar que tenga que repetir información sin necesidad. Piensa si se pueden cambiar las expectativas del personal o del servicio, en lugar de dejar toda la carga en la persona. Explica una cosa cada vez.

Probar algo en compañía

Separa las necesidades inmediatas de las cosas que pueden esperar, completa una parte manejable de una tarea o haz una pausa si la persona quiere. El plan debe reducir las exigencias, no convertirse en otra obligación.

Decisión y seguridad

No tomes decisiones por la persona sin la autoridad o el consentimiento necesarios. Respeta la intimidad y los límites profesionales. Comunica las necesidades esenciales no atendidas, las preocupaciones de protección o los riesgos graves a través del procedimiento correspondiente. No presentes los problemas estructurales como fallos individuales.

Una posible invitación:«¿De qué podría ocuparme o qué podría facilitarte ahora?»

Nota sobre la evidencia:NICE NG197, los estándares nacionales australianos de atención sanitaria, las orientaciones canadienses centradas en la recuperación y NHS England respaldan una comunicación comprensible, el trabajo en colaboración y la atención a las cargas relacionadas con los servicios. Las acciones concretas para reducir la carga son adaptaciones prácticas, no tratamientos validados para la sobrecarga.

Cuando alguien se siente sin ánimo o se aísla

Comprender qué puede estar pasando

El aislamiento, la falta de energía y la menor participación pueden tener muchas causas: enfermedad física, dolor, cansancio, duelo, efectos de la medicación, miedo o preferencias personales. Pregunta qué le importa a la persona en lugar de suponer que le falta motivación.

Considerar qué se puede cambiar

Aborda las barreras a la participación: actividades inaccesibles, falta de materiales o transporte, dolor, expectativas excesivas u horarios poco adecuados. Deja espacio para el descanso y la intimidad. A veces basta con estar presente en silencio; no exijas que la persona participe para demostrar progreso.

Ofrecer apoyo práctico

Ofrece compañía, ayuda con la comida y la bebida o con las rutinas cotidianas, y facilita el contacto con personas de confianza si así lo quiere. Haz más accesibles sus aficiones habituales sin fijar objetivos de participación. Deja que decida qué tiene sentido para ella, incluso si prefiere descansar.

Probar algo en compañía

Propón una opción pequeña y significativa para esa persona: preparar una bebida, escuchar música elegida, cuidar el jardín, hacer algo creativo, salir al aire libre o realizar un movimiento accesible. Participar puede consistir en elegir, mirar, ayudar un momento o simplemente estar presente.

Decisión y seguridad

No interpretes el rechazo como un fracaso ni la participación como prueba de mejoría. Los cambios marcados en el funcionamiento, la incapacidad para atender necesidades básicas, los síntomas físicos preocupantes o las inquietudes sobre autolesiones y suicidio requieren una valoración y una respuesta adecuadas.

Una posible invitación:«¿Te apetece que te acompañe o hay alguna cosa pequeña que te gustaría que hiciéramos juntos?»

Nota sobre la evidencia:La activación conductual estructurada cuenta con evidencia para la depresión (NICE NG222; revisión Cochrane de Uphoff et al., 2020), pero las actividades informales en compañía no equivalen a una terapia. Helsedirektoratet y las orientaciones canadienses centradas en la recuperación respaldan las actividades significativas y los objetivos definidos por cada persona.

Ha pasado algo

Comprender qué puede estar pasando

Después de un suceso aterrador, angustioso o que cambia la vida, cada persona puede necesitar un tipo de ayuda distinto. No des por hecho que tendrá una reacción emocional concreta, un diagnóstico o deseos de hablar. Respeta las costumbres personales, culturales y espirituales relacionadas con el duelo. Nunca esperes que alguien encuentre un sentido positivo a su sufrimiento.

Considerar qué se puede cambiar

Da prioridad a la seguridad inmediata, la intimidad, la información clara y el acceso a lo necesario. Reduce la exposición evitable a situaciones angustiosas y la necesidad de repetir lo ocurrido. Considera si el propio servicio debe cambiar algo.

Ofrecer apoyo práctico

Dentro de tus funciones, ayuda con la comida, el transporte, las pertenencias, el alojamiento, las citas, el contacto con personas de confianza u otras necesidades inmediatas. Explica claramente qué ocurrirá después y organiza un seguimiento adecuado cuando sea útil. Si es posible, procura que haya continuidad con personas de confianza para evitar que tenga que repetir lo sucedido.

Probar algo en compañía

Si la persona quiere, ofrécele compañía tranquila, una rutina conocida, una tarea práctica o un ritual que tenga sentido para ella. Escucha a quien quiera hablar y no insistas con quien no quiera.

Decisión y seguridad

No exijas que relate lo ocurrido ni que exprese sus emociones. No ofrezcas una sesión de revisión psicológica centrada en revivir los hechos para prevenir o tratar el TEPT; esto no impide las conversaciones de apoyo habituales ni las revisiones posteriores al incidente que correspondan. Explica los límites de la confidencialidad. Las lesiones, el peligro inmediato, el abuso, los problemas de protección, las necesidades esenciales no atendidas o los riesgos importantes para la salud mental requieren una respuesta de emergencia, clínica o de protección adecuada.

Una posible invitación:«¿Quieres compañía o hay algo práctico con lo que pueda ayudarte ahora?»

Nota sobre la evidencia:Los primeros auxilios psicológicos de la OMS y NHS Scotland respaldan una ayuda práctica y respetuosa; NHS England y SAMHSA destacan la atención informada por el trauma. NICE NG116 desaconseja la revisión psicológica centrada en revivir los hechos para prevenir o tratar el TEPT, pero no las conversaciones de apoyo habituales. No afirmes que los primeros auxilios psicológicos previenen el TEPT.

Investigación y evidencia

Este recurso se basa en orientaciones profesionales sobre comunicación comprensible, decisiones compartidas, desescalada respetuosa y apoyo práctico después de sucesos angustiosos. Su objetivo es ayudar a quienes ofrecen apoyo a responder a lo que importa a la persona y facilitar la atención cotidiana.

Una revisión de 2026 de 42 estudios con 8.798 participantes encontró que los enfoques de toma de decisiones compartida pueden mejorar la participación inmediata, el intercambio de información y los procesos de decisión. Los estudios utilizaron distintos diseños y trataron decisiones clínicas en casos de enfermedad mental grave; aplicar estos resultados al apoyo cotidiano es indirecto y los beneficios a más largo plazo son menos seguros.

La investigación sobre activación conductual estructurada respalda las actividades significativas para la depresión en adultos, también en formatos de autoayuda. La guía de implementación de autoayuda de la OMS de 2026 describe modalidades con y sin acompañamiento; los programas evaluados que destaca incluían cinco semanas de apoyo breve por parte de personas formadas y supervisadas. Estos resultados sirven de contexto para este recurso. Las actividades informales en compañía no equivalen a un programa de tratamiento.

Las guías clínicas, los estándares nacionales de los servicios y las orientaciones centradas en la recuperación respaldan muchos de estos principios. La evidencia directa varía según la actividad, y las recomendaciones nacionales pueden corresponder a un entorno o sistema jurídico concreto.

Fuentes principales

- Toma de decisiones compartida en enfermedad mental grave — revisión sistemática (2026)
- Activación conductual para la depresión — revisión exhaustiva (2026)
- OMS — Intervenciones psicológicas de autoayuda (2026)
- NICE NG10 — Violencia y agresividad
- NICE NG197 — Toma de decisiones compartida
- NICE CG113 — Trastorno de ansiedad generalizada
- NICE CG31 — Trastorno obsesivo-compulsivo

- NICE NG222 — Depresión en adultos
- NICE NG116 — Trastorno de estrés postraumático
- OMS — Primeros auxilios psicológicos
- OMS — Servicios comunitarios de salud mental
- NHS England — Atención hospitalaria informada por el trauma y consciente del daño
- NHS Scotland — Qué hacer después de un suceso traumático
- Helsedirektoratet — Enfoques para la atención al paciente
- Comisión de Salud Mental de Canadá — Práctica centrada en la recuperación
- Te Pou — Orientaciones sobre modulación sensorial
- Comisión Australiana de Seguridad y Calidad en la Atención Sanitaria — Estándares de atención primaria y comunitaria
- SAMHSA — Enfoques informados por el trauma
- AHRQ — Método de comprobación de la comprensión (herramientas de alfabetización sanitaria)
- Cochrane — Uphoff et al. (2020), terapia de activación conductual para la depresión en adultos

La revisión general de la investigación se actualizó el 8 de noviembre de 2026. Las fuentes respaldan enfoques generales y principios de atención; no se han evaluado directamente todas las actividades individuales. Sigue pendiente una auditoría completa de las demás fuentes y una revisión clínica específica para cada entorno. Aplica las orientaciones locales pertinentes y el criterio profesional.